

Traumatisme de la face et de la face antérieure du cou

Plaie de la face

À l'exception des éraflures sans gravité, une plaie de la face ou du cou doit être considérée et prise en charge comme une plaie grave du fait de sa localisation :

- appliquer la conduite à tenir face à une plaie grave ;
- laisser les corps étrangers en place :
 - même s'ils sont transfixiants¹,
 - sauf s'ils entraînent une obstruction des voies aériennes.

Atteinte traumatique de l'œil

- appliquer la conduite à tenir face à une plaie grave en présence d'une plaie à l'œil ;
- demander à la victime de rester à plat dos² dans la mesure du possible. ;
- recouvrir³ les deux yeux par des compresses stériles.

Traumatisme dentaire

- appliquer la conduite à tenir face à une plaie en présence d'un traumatisme dentaire.

Fracture de la face (mandibule, maxillaire supérieur, os du nez)⁴

- installer la victime sur le côté ;
- appliquer la conduite à tenir devant une détresse respiratoire si nécessaire.

Si le traumatisme est mineur, appliquer la conduite à tenir devant un saignement de nez.

Dans tous les cas

- si la victime perd connaissance, appliquer la conduite à tenir adaptée ;
- demander un avis médical et respecter les consignes données.

¹ Qui traverse de part en part.

² Cette position évite une aggravation éventuelle de la lésion de l'œil.

³ Sans appuyer et seulement s'il n'existe pas de corps étrangers dont la mobilisation pourrait aggraver la lésion oculaire.

⁴ Ces lésions sont susceptibles de provoquer un saignement abondant qui peut s'écouler et encombrer les voies aériennes, pouvant engendrer une détresse respiratoire.